阿尔兹海默症智能诊断系统

核心特点

- □ 多模态数据融合分析
- □ AI辅助诊断算法
- □ 实时风险评估
- □ 个性化治疗建议
- □ 12个月进展预测

系统特点：精准诊断、智能分析、全面评估

报告目录

一、患者基本信息 3
二、诊断结果概要 4
三、脑部图像分析 5
四、脑区风险热力图 6
五、关键风险指标 7
六、12个月进展预测 8
七、个性化指导建议 9
八、医生信息和报告说明 10

阿尔兹海默症诊断报告

医院名称：神经内科中心医院

系统版本：阿尔兹海默症诊断系统 v3.0.0

一、患者基本信息

生活方式信息

生活方式	值
每周运动次数	3
每天睡眠时间(小时)	7
饮食习惯	中等
每周社交活动次数	2
吸烟状况	从不吸烟
饮酒频率	偶尔饮酒

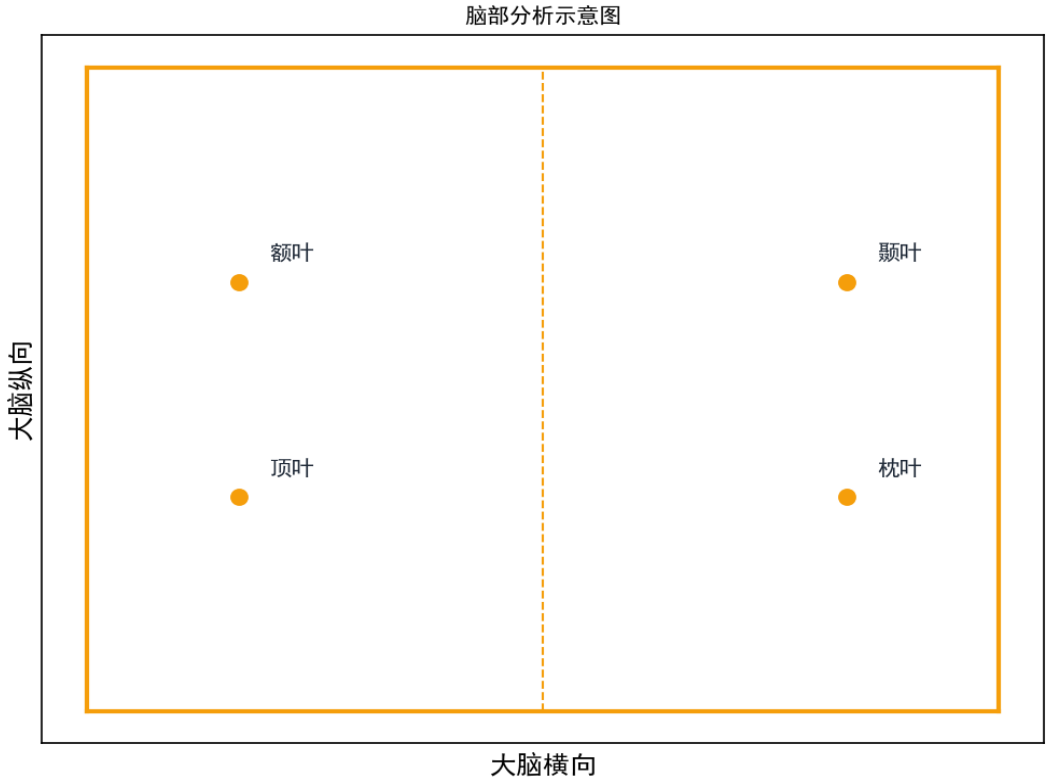
项目	值
姓名	测试患者
年龄	65岁
性别	男
教育年限	12年
联系方式	138-xxxx-xxxx
病史	无特殊病史

二、诊断结果概要

项目	结果
诊断结论	早期轻度认知障碍
置信度	85.42%
风险评分	0.62
风险等级	高风险

三、脑部图像分析

图1：脑部结构分析图 – 显示早期轻度认知障碍状态下的脑区分布情况

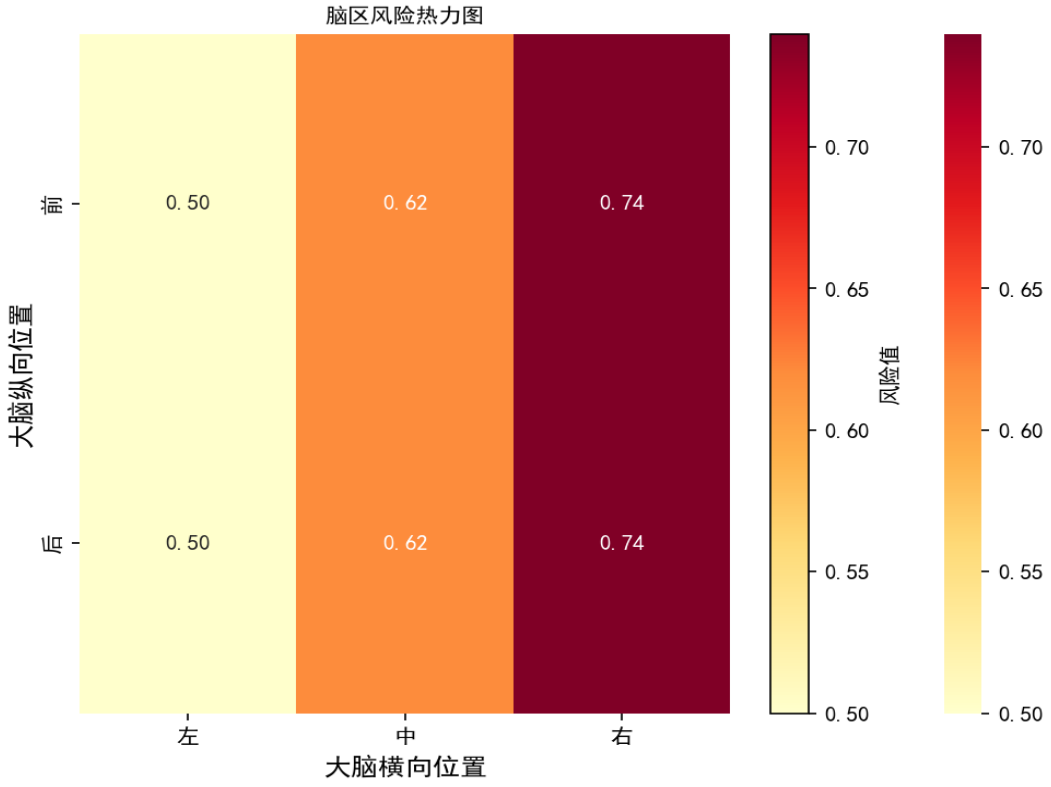


- ☐ 额叶(FL)：负责执行功能和决策
- ☐ 颞叶(TL)：负责记忆和语言处理
- ☐ 顶叶(PL)：负责空间认知和注意力

☐ 枕叶(OL)：负责视觉信息处理

四、脑区风险热力图

图2：脑区风险热力图 – 展示不同脑区的风险程度(风险值越高颜色越深)



☐ 颜色说明：黄色→橙色→红色 表示风险程度从低到高

☐ 额叶和颞叶是阿尔茨海默病最常影响的脑区

☐ 海马体负责记忆形成，是疾病早期受影响的关键区域

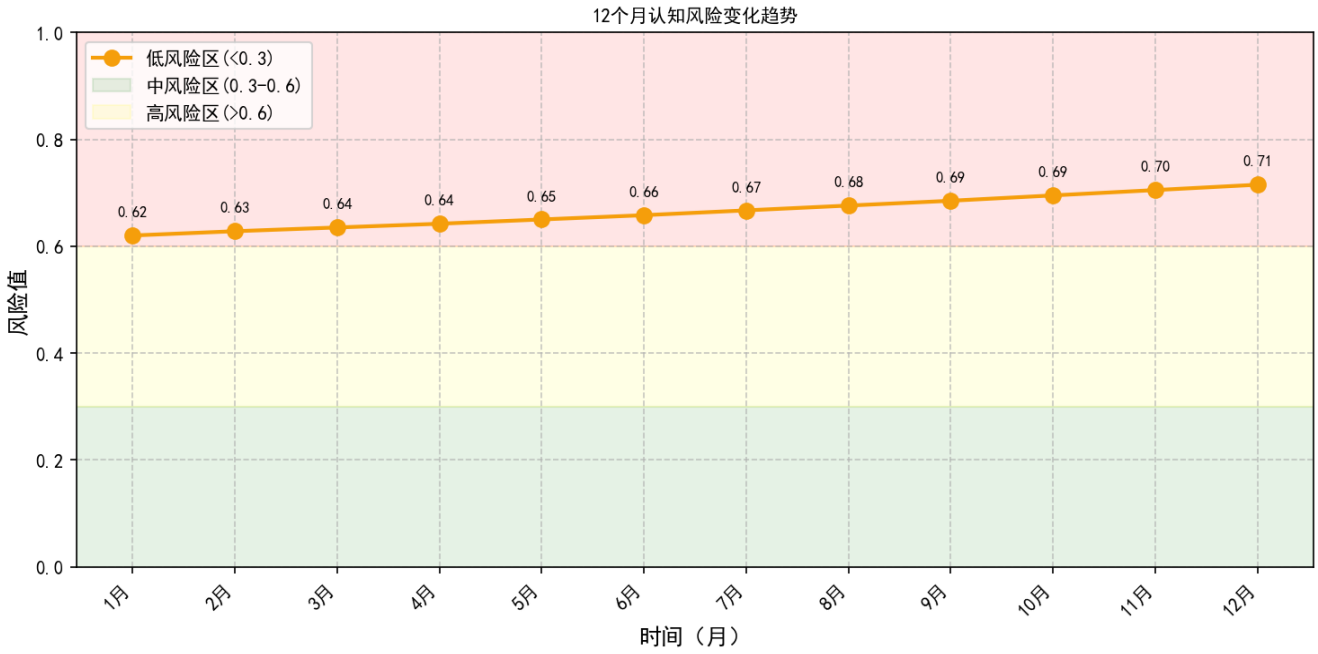
五、关键风险指标

指标名称	检测值	风险等级	参考说明

年龄风险	65岁	中风险	年龄越大风险越高。正常范围：60岁以下风险较低，60-75岁风险中等，75岁以上风险较高
教育程度	12年	中风险	教育年限越少风险越高。正常范围：12年以上教育为低风险，9-12年为中等风险，9年以下为高风险
生活方式	一般	中风险	不良生活方式增加风险。正常范围：健康生活方式为低风险，一般生活方式为中等风险，不良生活方式为高风险
认知功能	轻度下降	高风险	认知功能下降是重要指标。正常范围：认知功能正常为低风险，轻度下降为中等风险，明显下降为高风险
社会活动	较少	中风险	无详细参考信息

六、12个月进展预测

图3：12个月认知风险变化趋势预测图



时间	风险值	风险变化
1月	0.620	基准
2月	0.628	→稳定
3月	0.635	→稳定
4月	0.642	→稳定
5月	0.650	→稳定
6月	0.658	→稳定
7月	0.667	→稳定
8月	0.676	→稳定
9月	0.685	→稳定
10月	0.695	→稳定
11月	0.705	↑上升
12月	0.715	↑上升

趋势分析：未来12个月风险值从0.620变化到0.715，总体上升0.095。

七、个性化指导建议

运动锻炼

1. 保持每周3-5次有氧运动，如快走、游泳等
2. 积极参与社交活动，保持与家人朋友的交流

饮食调理

1. 采用地中海饮食，多摄入鱼类、坚果和蔬菜水果

认知训练

1. 坚持认知训练，如阅读、下棋、学习新技能
2. 每6个月进行一次认知功能评估复查

社交活动

1. 积极参与社交活动，保持与家人朋友的交流

定期复查

1. 每6个月进行一次认知功能评估复查

八、医生信息和报告说明

项目	值
主治医生	神经内科专家
科室	神经内科
联系方式	010-xxxxxxxx
报告日期	2026-04-19

报告说明

1. 本报告由阿尔兹海默症智能诊断系统自动生成，基于多模态数据分析算法。
2. 诊断结果仅供参考，最终诊断应以临床医生综合判断为准。
3. 建议患者定期进行认知功能评估，以便及时监测病情变化。
4. 保持健康的生活方式（规律运动、健康饮食、社交活动）对预防和延缓认知衰退有重要作用。
5. 如有疑问或不适，请及时就医咨询专业医生。

报告生成时间: 2026-04-19 20:13:25

报告编号: diagnosis_report_PAT_TEST_001_20260419_201324